

Mitmepalgeline üksildus SHARE vanemaealiste uuringu andmetel



Merike Sisask

sotsiaaltervishoiu professor, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
vanemteadur, Eesti demograafia keskus



Katrin Roosipuu

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö magistrant

Nii üksindus kui ka üksildus on (post)modernses ja individualistlikus ühiskonnas võtnud niisugused mõõtmed, et seda on nimetatud lausa 20. ja 21. sajandi epideemiaks (Alberti 2018, Snell 2017).

Üksilduse olemus ning üksilduse asjaolud

Nüüdsel ajal elab Euroopa kultuuriruumis üksinda neljandik kuni kolmandik, mõnes piirkonnas isegi kuni pool üle 65aastasest eakatest. Seejuures elavad Eesti eakad Euroopa Liidu keskmisega võrreldes sagedamini üksi, erinevused sugude vahel on märkimisväärsed. Kui Euroopa Liidus elas aastal 2017 üle 65aasta vanustest eakatest üksi keskmiselt 32,5% (meestest 22,4%; naistest 40,4%), siis Eestis on see koguni 43,6% (meestest 25,2%; naistest 53,1%) (Eurostat 2019).

Ent üksi olemine ja üksi elamine peegeldab vaid ühte tahku üksindusest ega pruugi midagi öelda üksilduse kohta selle sõna emotsionaalses ja sügavalt isiklikus tähenduses: näiteks võib inimene end üksildasena tunda ka siis, kui ta füüsiliselt üksinda ei olegi (Azeredo ja Afonso 2016). Thomas Dumm on oma raamatus „Üksildus kui elamise viis” (2010) kirjeldanud üksildustunnet kui osa tänapäeva

inimese põhiolemusest, mis sõltub vähe sotsiaalsest keskkonnast ning millega tuleb lihtsalt õppida elama. Niisiis enne, kui asuda üksindust/üksildust mõõtma ja analüüsima, tuleks jõuda selgusele selle mitmepalgelise nähtuse suhtes.

Üksilduse kohta on olemas rohkesti definitsioone ja teooriaid ning eri keeltes ja kultuurides lisab selle tähendusele varjundeid keelekasutus. Ka eesti keeles võib esmapilgul sarnastel sõnadel või sõnapaaridel olla küllaltki erinev tähendusvarjund: üksi olemine (kedagi pole füüsiliselt läheduses), üksindus (sarnane üksi olemisele), üksijäetus (teiste poolt hüljatud olek), üksildus (üksijäetusega kaasnev negatiivne emotsioon). Sageli jääb piir üksilduse ja üksi olemise ehk üksinduse vahel üsna ebaselgeks. Üksildus kui tunne võib iga inimese jaoks olla küllaltki erinev, sisaldades endas sageli tühjuse või eraldatuse kogemust, mille tagajärjeks võib olla argielu toiminguid häiriv abitus, hüljatus, valu ja hirm (Tiwari 2013). Küllalt selge on aga erinevate uuringute tulemuste põhjal see, et üksi elamine ei tähenda ka eakate puhul ilmtingimata emotsionaalset üksildust (Andersson 1998; Hawkey ja Cacioppo 2010; Lim ja Kua 2011; Singh ja Misra 2009), kuna üksildustunde mõõdupuuks on eelkõige erinevus inimese soovitud

seisundi ning tema tegeliku olukorra vahel (de Jong-Gierveld 1987; Perlman ja Peplau 1981). Seega, üksildus võib olla, võrreldes üksi olemisega, dramaatiliselt erinev kogemus: üksi olles ei pruugi inimene tunda puudust mitte millestki, kuid üksildus on püsiv subjektiivne tunne, et midagi olulist elus puudub.

Uuringutes on leitud rohkesti seoseid üksilduse ja üldise tervise seisundi (Coyle ja Dugan 2012; Rico-Uribe jt 2016), kuid samuti erinevate haiguslike seisundite vahel nagu näiteks haprus (Herrera-Badilla jt 2015; Taube jt 2016), südame-veresoonkonnahaigused (Hegeman jt 2018; Thurston ja Kubzansky 2009), depressioon (Bodner ja Bergman 2016; Lim ja Kua 2011; Singh ja Misra 2009) ning kognitiivse võimekuse vähenemine (Hawkley ja Cacioppo 2010; Wilson jt 2007). Seejuures üksildus võib nendele haiguslikele seisunditele eelneeda, kuid ta võib olla ka haiguse ja sellega kaasnevate liikumis- ja suhtluspiirangute tagajärg. On leitud ka seoseid üksilduse ja üldise suremuse vahel (Holt-Lunstad jt 2015; Rico-Uribe jt 2016).

Seosed on leitud ka üksilduse ja demograafiliste ning sotsiaalmajanduslike tunnuste vahel: üksildus on suurem eakatel, kes on vanemas vanusegrupis ja majanduslikult vähem kindlustatud (Niedzwiedz jt 2016; Wilson jt 2007) ning kehvemate IT oskuste ja võimalustega (Chen ja Schulz 2016, Keränen jt 2017).

Eesti eakate üksildus SHARE andmetel

Eestis on regulaarselt uuritud individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja selle mõjutegureid, kasutades selleks üleeuroopalise vanemaaliste (50+) longituuduuringu SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) andmeid. Käesolevas artiklis on analüüsimiseks kasutatud kuuenda

küsitluslaine andmeid aastast 2015. Eesti valimi suurusks oli $n=6006$, vastajatest 39,2% olid mehed ja 60,8% naised.

Analüüsi keskseks tunnuseks oli üksildus. Üksildustunnet kui sügavalt isiklikku subjektiivset kogemust mõõdetakse tavaliselt enesehinnanguliste küsimustikega (Snell 2017), nii ka SHARE uuringus. Seekord oli kasutusel lühendatud versioon UCLA üksilduse skaalast – R-UCLA (Revised – University of California at Los Angeles Loneliness Scale) (Hughes jt 2004; Russell, Peplau ja Cutrona 1980). Skaala koosnes kolmest küsimusest: *Kui sageli te tunnete puudust seltsilistest?*; *Kui tihti te tunnete ennast kõrvalejätuna?*; *Kui tihti te tunnete, et olete teistest inimestest eraldatud?*. Igale küsimusele oli võimalik vastata skaalal 1–3 (*sageli, mõnikord, harva või mitte kunagi*). R-UCLA skaala võimalik koguskoor oli 3–9 ning koguskoori põhjal jaotati valim kolme rühma: *ei ole üksildane* (skoor 3), *mõnevõrra üksildane* (skoor 4), *üksildane* (skoor 5–9).

Sellise jaotuse järgi ei tundnud eakatest ennast üldse üksildasena 55% ($n=2871$), mõnevõrra üksildasena tundis 19% ($n=977$) ja üksildasena 26% ($n=1357$). Meeste ja naiste üksildustundes olulisi erinevusi ei olnud. Vanuse puhul oli märgata selge tendents – mida vanem inimene, seda suurem oli mõnevõrra üksildaste ja üksildaste osakaal. Kui näiteks 51–70-aastaste hulgas oli üksildaste osakaal valimi keskmisest madalam (22%), siis 71–90-aastaste hulgas oli see tunduvalt kõrgem (31%) ning üle 90-aastaste hulgas veelgi kõrgem (54%).

Alljärgnevalt on välja toodud mõned seosed erinevate tunnuste ja üksilduse vahel. Tunnuste valik on tehtud, lähtudes kolmest printsiibist: tunnusel on varasemate uuringute põhjal eeldatav seos üksildusega, tunnus on olemas SHARE küsimuste hulgas, andmeanalüüsi käigus leitud seos

on hinnatuna hii-ruut testiga statistiliselt olulisel $p < 0.001$ tasemel.

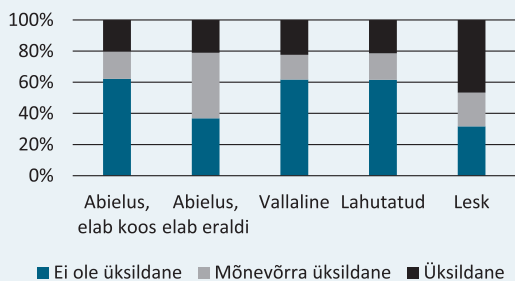
Demograafilistest ja sotsiaalmajanduslikest tunnustest jäid sõelale pereseis, töötamine, majanduslik toimetulek, rahapuudus, auto olemasolu ning IT kasutamise oskused. Nimetatud tunnused vastavalt kas soodustavad või takistavad suhtlust ja toimetulekut.

Joonisel 1 on kujutatud pereseisu ja selle seoseid üksildusega. Teistest harvem olid üksildased koos elavad abielus eakad, vallalised ning lahutatud. Esiletõstmist vääriiva tähelepanekuna võib välja tuua, et rohkem oli üksildasi leskede hulgas (47%) ning mõnevõrra üksildasi küll abielus, aga

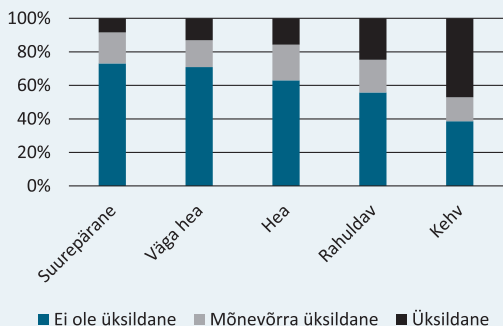
eraldi elavate hulgas (42%).

Seoses töötamisega ilmnes ootuspäraselt, et sagedamini on üksildasi puudega inimeste, pensionäride ning muul põhjusel koduste eakate hulgas, harvem tööl käivate seas.

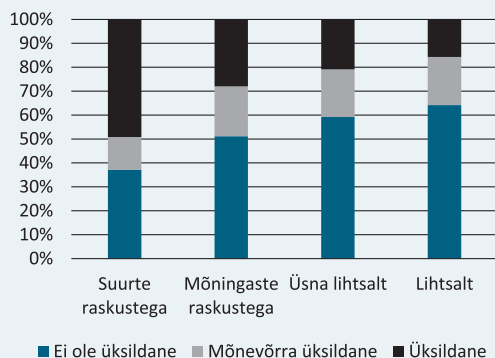
Väga selge seos oli majandusliku toimetuleku ning üksilduse vahel (joonis 2): märkimisväärselt enam üksildasi oli suurte raskustega toimetulevate eakate hulgas (49%) võrreldes nendega, kes ütlesid, et neil on majanduslikult lihtne toime tulla (16%). Üksildustunnet esines vähem nendel eakatel, kellel oli auto (üksildasi vastavalt 22% vs 34%) ning kelle IT oskused olid paremad (suurepärase IT kasutamise oskustega



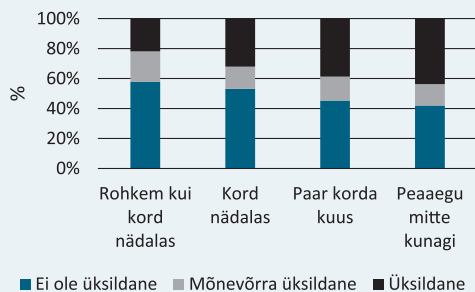
Joonis 1. Perekonnaseis ja üksildus



Joonis 3. Hinnang oma tervisele ja üksildus



Joonis 2. Majanduslik toimetulek ja üksildus



Joonis 4. Mõõdukalt füüsilist tegevust nõudvad tegevused ja üksildus

eakate hulgas oli üksildasi 13% ning mitte kunagi arvutit kasutanute hulgas 35%).

Kehalise ja vaimse tervise ning haigustega seotud tunnustest jäid sõelale hinnang oma tervisele, pikaajaline või krooniline haigus, haigusest tulenevad tegevuspiirangud, kurbus või depressioon viimase kuu jooksul, suitsiidimõtted.

Eakate enesehinnang tervisele oli väga tugevas seoses üksildusega (joonis 3). Oma tervisele suurepärase hinnangu andnud eakatest oli üksildasi 8%, kehva hinnangu andnutest 47%.

Seosed olid tugevad ka muude tervise/haigusega seotud tunnuste puhul. Pikaajalise või kroonilise haigusega inimestest oli üksildasi 29% (vs 17% nendest, kellel niisugust haigust ei olnud). Kui eaka tegevused olid kehva tervise tõttu väga piiratud, oli üksildaste osakaal 43%, kui mitte nii väga piiratud, siis 23% ning kui ei olnud üldse piiranguid, siis 16%. Depressiivsetest inimestest oli üksildasi 38% ning kui eakas tunnistas küsitlusuuringus suitsidaalsete mõtete esinemist, siis nende hulgas oli üksildasi koguni 59%.

Suhtlusvõrgustikku ja aktiivset tegutsemist iseloomustavate tunnustena jäid sõelale tegelemine lastelastega, rahapuudus tegevuste piirajana, meeldivate tegevuste olemasolu, mõõdukalt füüsilist pingutust nõudvad tegevused.

Lastelastega tegelevate eakate hulgas oli üksildasi 21% ning nendest, kes lastelastega ei tegelnud, oli üksildasi 32%. Rahapuudusest tulenevate tegevuspiirangutega eakate hulgas oli üksildasi 36%, kui aga rahapuudus tegevusi kunagi ei piiranud, oli üksildasi 19%. Eakad, kes mainisid mingeidki meeldivaid tegevusi, olid harvem üksildased kui need, kes meeldivaid tegevusi ei nimetanud (vastavalt 24% vs 41%). Kõige tugevam seos ilmnis mõõdukat füüsilist pingutust nõudvate tegevuste ja üksilduse

vahel: kui eakas kasvõi korra nädalas end füüsiliselt pingutas, oli üksildustunnet vähem, ning kui ta tegi seda rohkem kui kord nädalas, oli erinevus märkimisväärne (joonis 4).

Järeldused – mida soovitada üksildustunde leevendamiseks

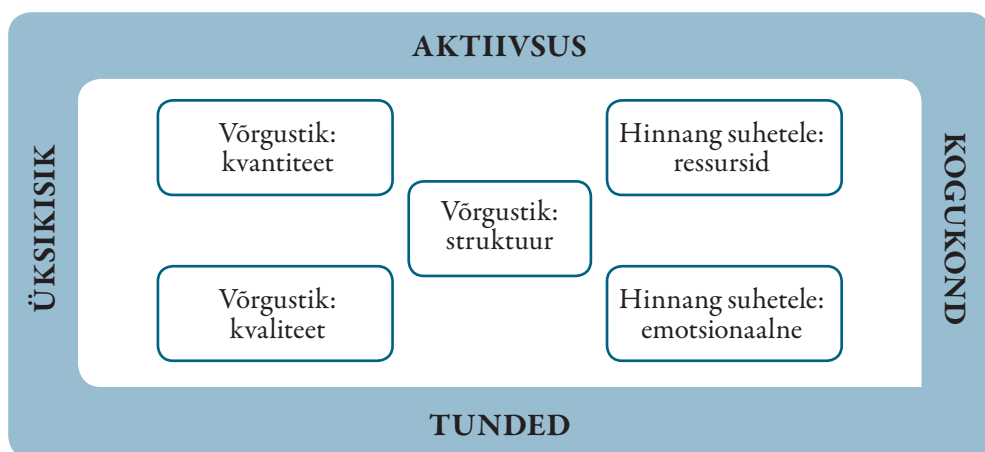
Nagu kirjanduse analüüsist ja SHARE Eesti andmetest näha, on üksildustunne seotud demograafiliste, sotsiaalmajanduslike ning tervist, aktiivset eluviisi ja suhtlusvõrgustikke iseloomustavate tunnustega. Osa neist on kergemini, osad raskemini mõjutatavad. Miks on üksildus ohtlik? Sest üksildustunnel on omadus aja jooksul tugevneda ning kiirendada seeläbi inimese psühholoogilist vananemist. Võtmesõnaks on ennetustöö ja sekkumine.

Üksildustunde leevendamiseks ilmselt ei piisa ühe konkreetse tegevuse elluviimisest, vaid sekkumine peab olema kompleksne ja järjepidev. Wang ja kolleegid (2017) on välja pakkunud mudeli, mis kirjeldab sotsiaalset isolatsiooni ning selle mõjutegurid (joonis 5). Mudelisse on kaasatud nii sotsiaalset võrgustikku kui inimese enda subjektiivset hinnangut iseloomustavad mõjutegurid, kusjuures üheks oluliseks teguriks teiste hulgas on subjektiivselt kogetud üksildustunne. Mudelisse kaasatud viie valdkonna lühike kirjeldus selle autorite kohaselt on järgmine:

1. Võrgustik

1.1. kvantiteet – suhete võrgustiku suurus (inimeste arv), kontaktide sagedus (igapäevane, iganädalane, igakuine)

1.2. struktuur – suhete võrgustiku tihedus (kui palju inimest ümbritsevad erinevad võrgustikud omavahel seotud on), kui suur on sugulaste ja muude tuttavate, kolleegide, teenust osutavate spetsialistide osakaal



Joonis 5. Sotsiaalne isolatsioon ja sellega seonduvad mõisted: kontseptuaalne kaardistus.

Allikas: (Wang jt 2017)

1.3. kvaliteet – inimese poolt subjektiivselt tajutud kvaliteet, usalduslike suhete olemasolu (kas saab lisaks praktilistele asjadele rääkida muredest ja tunnetest), mõõdikuks võiks olla hinnang, kellest tuntaks tõeliselt puudust, kui enam kunagi ei kohtuks

2. Hinnang suhetele

2.1. ressursid – ligipääs toimetuleku ressursidele sotsiaalse võrgustiku toel (kodune majapidamine, professionaalne abi, isiklikud oskused, probleemilahendamise oskused)

2.2. emotsionaalne – koetud üksildustunne, mis ei põhine objektiivsetel suhete võrgustikku iseloomustavatel kvantiteedi- või kvaliteedinäitajatel.

Hinnang nendele viiele valdkonnale aitab mudeli autorite sõnul eristada kolme olulist asja: (1) kellegi sotsiaalse suhtevõrgustiku objektiivne *vs* subjektiivselt tunnetatud kvaliteet; (2) isiklikud lähedased suhted *vs* üldine sotsiaalne/ inimeste vaheline

ühendus; (3) materiaalne (praktiline) *vs* immateriaalne (emotsionaalne) suhetest saadav tugi.

Toetudes analüüsile võib üksildustunde leevendamiseks soovitada, et eakad püüaksid säilitada aktiivset eluviisi, liikudes võimalikult palju ja harrastades endale meelepäraseid ja rõõmu valmistavaid tegevusi. Väga oluline on ka suhtlemine ja suhete hoidmine nii oma lähedaste kui ka teiste eakatega ning ka nooremate inimestega. Suhtlust eri põlvkondade vahel hõlbustavad digimaaailma võimalused. Soovime, et omaksed, naabrid, sotsiaaltöötajad jt eakatega kokku puutuvad kogukonnaliikmed suhtleksid nendega rohkem, see aitab varakult märgata majanduslikest raskustest või tervislikust seisundist tuleneva tegevuspiiranguga eakaid ning mõelda, kuidas pakkuda sobivaid suhtlemisvõimalusi ja tegevusi.

S

Tänusõnad. Käesoleva artikli valmimist on toetanud Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (personaalse uurimistoetuse rühmagrant „Eesti rahvastiku nüüdisareng: kestlikuma ühiskonna poole viiva tee otsingul”, projekt nr PFG71).

Viidatud allikad

- Alberti, F. B.** (2018). This 'Modern Epidemic': Loneliness as an Emotion Cluster and a Neglected Subject in the History of Emotions. *Emotion Review*, 10(3), 242–254. doi: 10.1177/1754073918768876.
- Andersson, L.** (1998). Loneliness research and interventions: a review of the literature. *Aging & Mental Health*, 2(4), 264–274. doi: 10.1080/13607869856506.
- Azeredo, Z. de A. S., Afonso, M. A. N.** (2016). Loneliness from the perspective of the elderly. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 19(2), 313–324. doi: 10.1590/1809-98232016019.150085.
- Bodner, E., Bergman, Y. S.** (2016). Loneliness and depressive symptoms among older adults: The moderating role of subjective life expectancy. *Psychiatry Research*, 237, 78–82. doi: 10.1016/j.psychres.2016.01.074.
- Chen, Y.-R. R., Schulz, P. J.** (2016). The Effect of Information Communication Technology Interventions on Reducing Social Isolation in the Elderly: A Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 18(1). doi: 10.2196/jmir.4596.
- Coyle, C. E., Dugan, E.** (2012). Social Isolation, Loneliness and Health Among Older Adults. *Journal of Aging and Health*, 24(8), 1346–1363. doi: 10.1177/0898264312460275.
- de Jong-Gierveld, J.** (1987). Developing and Testing a Model of Loneliness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(1), 119–128. doi: 10.1037/0022-3514.53.1.119.
- Dumm, T.** (2010). Loneliness as a Way of Life. Harvard University Press.
- Eurostat.** (2019). Allalaetud 28.03.2019. <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
- Hawkey, L. C., Cacioppo, J. T.** (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, 40(2), 218–227. doi: 10.1007/s12160-010-9210-8.
- Hegeman, A., Schutter, N., Comijs, H., Holwerda, T., Dekker, J., Stek, M., Mast, R.** (2018). Loneliness and cardiovascular disease and the role of late-life depression. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, (1), 65. doi: 10.1002/gps.4716.
- Herrera-Badilla, A., Navarrete-Reyes, A. P., Avila-Funes, J. A., Amieva, H.** (2015). Loneliness is associated with frailty in community-dwelling elderly adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 63(3), 607–609. doi: 10.1111/jgs.13308.
- Holt-Lunstad, J., Baker, M., Harris, T., Stephenson, D., Smith, T. B.** (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227–237. doi: 10.1177/1745691614568352.
- Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkey, L. C., Cacioppo, J. T.** (2004). A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys. *Research on Aging*, 26(6), 655–672. doi: 10.1177/0164027504268574.
- Keränen, N. S., Kangas, M., Immonen, M., Similä, H., Enwald, H., Korpelainen, R., Jämsä, T.** (2017). Use of Information and Communication Technologies Among Older People With and Without Frailty: A Population-Based Survey. *Journal Of Medical Internet Research*, 19(2), e29–e29. doi: 10.2196/jmir.5507.
- Lim, L. L., Kua, E.-H.** (2011). Living alone, loneliness, and psychological well-being of older persons in Singapore. *Current Gerontology and Geriatrics Research*. doi: 10.1155/2011/673181.
- Niedzwiedz, C. L., Richardson, E. A., Tunstall, H., Shortt, N. K., Mitchell, R. J., Pearce, J. R.** (2016). The relationship between wealth and loneliness among older people across Europe: Is social participation protective? *Preventive Medicine*, 91, 24–31. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.07.016.
- Perlman, D., Peplau, A.** (1981). Toward a Social Psychology of Loneliness. Kogumikus: Duck, R., Gilmour, R. (toim.) Personal Relationships in Disorder. London: Academic Press.
- Rico-Uribe, L. A., Caballero, F. F., Martín-María, N., Cabello, M., Ayuso-Mateos, J. L., Miret, M.** (2018). Association of loneliness with all-cause mortality: A meta-analysis. *PLOS ONE*, 13(1), e0190033. doi: 10.1371/journal.pone.0190033.

- Rico-Uribe, L. A., Caballero, F. F., Olaya, B., Tobiasz-Adamczyk, B., Koskinen, S., Leonardi, M., Haro, J. M., Chatterji, S., Ayuso-Mateos, J. L., Miret, M.** (2016). Loneliness, Social Networks, and Health: A Cross-Sectional Study in Three Countries. *PLOS ONE*, 11(1), e0145264. doi: 10.1371/journal.pone.0145264.
- Russell, D., Peplau, L. A., Cutrona, C. E.** (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(3), 472–480. doi: 10.1037/0022-3514.39.3.472.
- Singh, A., Misra, N.** (2009). Loneliness, depression and sociability in old age. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(1), 51–53. doi: 10.4103/0972-6748.57861.
- Snell, K. D. M.** (2017). The rise of living alone and loneliness in history. *Social History*, 42(1), 2–28. doi: 10.1080/03071022.2017.1256093.
- Taube, E., Jakobsson, U., Midlov, P., Kristensson, J.** (2016). Being in a Bubble: the experience of loneliness among frail older people. *Journal of Advanced Nursing*, (3), 631. doi: 10.1111/jan.12853.
- Thurston, R. C., Kubzansky, L. D.** (2009). Women, Loneliness, and Incident Coronary Heart Disease. *Psychosomatic Medicine*, 71(8), 836–842. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181b40efc.
- Tiwari, S. C.** (2013). Loneliness: A disease? *Indian Journal of Psychiatry*, 55(4), 320–322. doi: 10.4103/0019-5545.120536.
- Wang, J., Lloyd-Evans, B., Giacco, D., Forsyth, R., Nebo, C., Mann, F., Johnson, S.** (2017). Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, (12), 1451. doi: 10.1007/s00127-017-1446-1.
- Wilson, R. S., Krueger, K. R., Arnold, S. E., Schneider, J. A., Kelly, J. F., Barnes, L. L., Tang, Y., Bennett, D. A.** (2007). Loneliness and risk of Alzheimer disease. *Archives Of General Psychiatry*, 64(2), 234–240. DOI: 10.1001/archpsyc.64.2.234.